



INFORME DE AUDITORÍA EN HABILITACIÓN

En el Municipio de la unión (Valle) el día 6 de abril, se realizó auditoría del Cumplimiento de las Condiciones del Sistema Único de Habilitación conforme a lo previsto en el Decreto 1011 de 2006, Resolución 3100 de 2019 y demás normatividad aplicable vigente.

Nombre o razón social del prestador	María Angélica Peña Cabrera
Clase de prestador:	Profesional independiente
Servicio:	Odontología general - Ortodoncia
Cedula de ciudadanía	1113782039
Sedes (2)	La Unión (Valle)

A continuación, se relacionan solamente los criterios incumplidos o hallazgos:

SERVICIOS PRESTADOS Y NO HABILITADOS:

Servicio de ortodoncia y otras especialidades.

2. CONDICIONES TÉCNICO-CIENTÍFICAS:

1. ESTANDAR DE TALENTO HUMANO:

Hallazgos:

Se realizó auditoría de las hojas de vida y se evidenció que la auxiliar Paula Andrea restrepo no cuenta con los documentos soporte como diploma, acta de grado, registro profesional, RETHUS, copia de vacunas incluyendo COVID, curso de víctimas de violencia sexual y cédula.

La Dra. Angélica Peña no cuenta con curso de víctimas de violencia sexual, diploma de odontóloga, acta de grado y registros profesionales.

2. INFRAESTRUCTURA:

Hallazgos:

No se evidencia RETIE y plan de ajustes de mantenimiento eléctrico realizado por un ingeniero electricista.



Se requiere rampa de acceso para la puerta de ingreso y consultorio.

El prestador de salud no cuenta con concepto sanitario para la visita de saneamiento se recomienda tener los siguientes documentos (PEGHIRS, uso del suelo para salud, estudio de vertimientos, certificado de bomberos, fumigación. No se evidencia que el prestador de servicios de salud tenga una copia de los conceptos sanitarios de los servicios de gestión de residuos y control de vectores (fumigación).

No se evidencia ambiente de aseo, se encuentra inmerso en el baño.

No se evidencia media caña en uniones techo/pared, pared/pared y guardaescobas del consultorio.

No se evidencia señalización del proceso en el área de esterilización. (desinfección, lavado, secado, etiquetado – empaque y esterilización).

El área de esterilización no cuenta con un proceso unidireccional, no cuenta con superficies lisas, se evidencia cerámica con hendiduras. Humedad en la parte baja e interna de los cajones.

No cuenta con barrera física fija o móvil entre las unidades odontológicas.

Las condiciones de orden, aseo, limpieza y desinfección no son evidentes ni responde a un proceso dinámico de acuerdo con los servicios prestados, se evidencia telaraña en el consultorio.

Se evidencia humedad en el ambiente de sala de espera y consultorio.

La pared del consultorio en algunas áreas no se evidencia la superficie lisa.

Los pisos deben ser resistentes a factores ambientales, deben ser continuos, antideslizantes, impermeables, lavables, sólidos, resistentes a procesos de lavado y desinfección. Cuando se tengan dilataciones y juntas, estas deben ser selladas de manera que ofrezcan continuidad de la superficie.

No se evidencia en la sala de espera unidades sanitarias discriminadas por sexo.

3. DOTACION:

Hallazgos:

Toda la documentación actual de este estándar se evidencia a nombre de Clinilaser. (hojas de vida y calibraciones).



El prestador de servicios de salud no cuenta con el registro de la relación de los equipos biomédicos requeridos para la prestación de servicios de salud actualizado 2024, este registro cuenta como mínimo con la siguiente información: nombre del equipo biomédico, marca, modelo, serie, Registro sanitario para dispositivos médicos o permiso de comercialización para equipos biomédicos de tecnología controlada, cuando lo requiera y Clasificación por riesgo, cuando el equipo lo requiera.

El prestador de servicios de salud no cuenta con un programa de capacitación en el uso de dispositivos médicos.

No se evidencia contrato, carta acuerdo o convenio firmado con un tercero para el mantenimiento de equipos biomédicos, incluyendo su hoja de vida.

No cuenta con los manuales en español y los permisos de comercialización o registro INVIMA de los equipos, puede ser análogo y descargados de internet.

*No se evidencia registro de inventario del instrumental.

Se evidencia hojas de vida de los equipos incompletas no cuenta con clasificación de riesgo y registro INVIMA.

No se evidencia programa y cronograma de mantenimiento de equipos biomédicos del año 2024.

No se evidencia documento, protocolo, acta o minuta en donde se evidencie que el número de equipos biomédicos que se requieren para la prestación de los servicios de salud en el marco de la seguridad del paciente es suficiente. El documento considera aspectos como: frecuencias de uso, tiempo de atención, tiempos de: limpieza, desinfección, reprocesamiento o esterilización cuando se requiera y en concordancia con las recomendaciones del fabricante, garantizando condiciones de uso seguro entre paciente y paciente. (capacidad instalada).

*No se evidencia registro de equipos industriales.

Se evidencia instrumental en mal estado (oxido).

No se evidencia calibraciones de equipos biomédicos anuales y mantenimientos preventivo semestral.



4. MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MEDICOS E INSUMOS:

Hallazgos:

No se evidencia registro de medicamentos y dispositivos diligenciado **mensualmente** incluyendo todos los ítems de normatividad. Este proceso se debe realizar mensualmente de acuerdo con las fichas técnicas de los insumos, incluyendo todos los medicamentos y dispositivos que estén actualmente en el consultorio.

Medicamentos:

Principio activo.
Forma farmacéutica.
Concentración
Lote.
Fecha de vencimiento.
Presentación comercial.
Unidad de medida.
Registro sanitario vigente o permiso cuando se autorice, expedido por el Invima.

Dispositivos médicos:

Nombre
Marca
Presentación comercial
Registro sanitario vigente o permiso de comercialización expedido por el Invima.
Clasificación del riesgo sanitario
Vida útil, cuando aplique
Fecha de vencimiento y lote.

No se evidencia diligenciamiento del formato de registro de las alertas sanitarias del INVIMA mensualmente y sus soportes.

La semaforización o metodología utilizada para control de fechas de vencimiento debe realizarse a todos los insumos que se encuentran en el consultorio y de acuerdo con los tiempos y colores establecidos en los documentos. *El prestador no cuenta con el documento del proceso de semaforización para el control de las fechas de vencimiento de los insumos.



No se evidencia paquete de manejo de derrames en el consultorio.

El prestador no cuenta con termohigrómetro y el diligenciamiento del registro de temperatura - humedad se debe realizar en la mañana y tarde.

El prestador no cuenta con los reportes de tecnovigilancia trimestrales.

Para la aplicación del protocolo de lavado de manos o higienización en los servicios de salud se debe realizar con jabón quirúrgico o antiséptico con registro INVIMA.

5. PROCESOS PRIORITARIOS:

Hallazgos:

*No se evidencia los cuatro formatos que aplica para el programa de seguridad del paciente para profesional independiente.

*No se evidencia protocolo para mejorar la seguridad en los procedimientos Qx.

*No se evidencia documento para mejorar la seguridad en los medicamentos.

*El prestador no cuenta con cronograma de capacitación del personal asistencial.

*No se evidencia guías clínicas con medicina basada en la evidencia de acuerdo con los servicios ofertados.

*El prestador no cuenta con los protocolos de odontología general y ortodoncia de los procedimientos realizados.

*No se evidencia documento de las practicas seguras del servicio.

② Se evidencia reúso de bolsas de esterilización, de acuerdo con las indicaciones del fabricante es de un solo uso.

La información documentada no es conocida mediante acciones de formación continua por el talento humano encargado y responsable de su aplicación, incluyendo el talento humano en entrenamiento, y no existe evidencia de su socialización.

*No se evidencia documento de la adopción, o adaptación o desarrollo de guías práctica clínica o protocolos basados en evidencia científica.



*El protocolo de reuso no se evidencia adaptado al servicio de odontología, ni cuenta con registro de reuso de fresas.

No se evidencia el etiquetado de cada paquete de esterilización que permita la trazabilidad de la esterilización (fecha de esterilización, fecha de vencimiento, carga, contenido(cuando aplique) y responsable).

6. HISTORIA CLINICA:

Hallazgos:

No se evidencia el manual de uso de la historia clínica de DENTALINK.

El prestador de servicios de salud que utilice mecanismos electrónicos, ópticos o similares para generar, recibir, almacenar, o disponer datos de la historia clínica y para conservarlos, debe **avaluar que el mecanismo utilizado cumple con características de: autenticidad, fiabilidad, integridad y disponibilidad del documento**, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente expedida por el Archivo General de la Nación, la Superintendencia de Industria y Comercio y el Ministerio de Tecnologías de información y Comunicaciones, para lo cual, **el prestador presentará un documento firmado por un ingeniero de sistemas con tarjeta profesional vigente, certificando que el mecanismo usado por el prestador cumple con la normatividad mencionada.**

Las historias clínicas cuentan con los componentes y los contenidos mínimos definidos en la normatividad, se evidencia espacios en blanco sin diligenciar.

No se evidencia consentimiento informado realizado para todas las historias clínicas realizadas.

No se evidencia el diligenciamiento del registro de esterilización incluyendo el ítem de carga con los controles químicos (por cada carga) y biológicos (cada 8 días).

7. INTERDEPENDENCIA:

No se evidencia contrato o acuerdo por escrito para ayudas diagnósticas (paquetes de ortodoncia, radiografías periapicales, panorámica etc....), entre las dos partes, en el que se establezca que el servicio interdependiente apoya el servicio principal.





NOVEDADES PARA REPORTAR POR EL PRESTADOR:

Apertura del servicio de ortodoncia y autoevaluación anual.

DISTINTIVO:

El prestador de servicios de salud que ostente el distintivo de habilitación en un servicio de salud se obliga a:

1. Mantener las condiciones de habilitación.
2. Imprimir el distintivo actualizado y fijarlo en un lugar visible al público.
3. No alterar ni modificar el distintivo de habilitación y velar por su buen estado y conservación.
4. Ofrecer la información a los usuarios sobre su propósito y significado.
5. Retirar el distintivo de habilitación en caso de deterioro, cierre temporal, cierre definitivo e inactivación de los servicios habilitados.
6. En caso de pérdida, el prestador de servicios de salud debe presentar a la secretaría de salud departamental o distrital correspondiente, o la entidad que tenga a cargo dichas competencias, copia de la denuncia interpuesta ante la autoridad competente.

Profesional que realizó la Auditoría:

Dra. Adriana Perdomo M.

Odontóloga – Especialista en Auditoría en Salud

Verificadora en habilitación.

“El desconocimiento de la norma, no lo exime de su cumplimiento”